

Información Paciente

Nombre : Filidor Gutierrez Morales

Rut : 4.746.138-3

N° Archivo : 0905396

N° Epicrisis

317114

Edad : 78a 10m 24d

Fecha Nacto: 07/09/1943

Sexo : Masculino

Dirección : Cabo Metalqui 1727, Villa Los Castaños 6

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 4558 6402

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Ingreso : 19/07/2022 02:13

Días Estadía: 12

Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Egreso : 31/07/2022 08:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Pie diabético

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Amputación Pierna - 24/07/2022 00:00 - Juan Pablo Ramos Perkis

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

Médicos: DM2 IR hace 20 años, HTA Crónica, ERC etapa V con HD trisemanal, UOB/HPB usuario de S. Foley, antecedente de 2 ACVs no secueledos, Amaurosis OD por glaucoma. IAM s/SDST (Nov 2021): enf de ADA, ACx, ACD. Stent medicado (ACD, descendente posterior)

Quirúrgicos: Cataratas bilateral, hernioplastía inguinal, prótesis cadera, quiste gl. Parotídeo operado

Fármacos: Insulina NPH 4 UI am, Sertralina 1 comp./día, AAS 100 mg/d, Clopidogrel 75 mg/d., Ác. Fólico, Carvedilol 25 mg am y 12.5 mg pm

Alergias: No refiere

Paciente con atcd descritos, recientemente hospitalizado por pie diabético derecho el cual requirió amputación infracondílea derecha debido a sepsis de foco cutáneo/óseo, evolucionando en malas condiciones posterior a cirugía con neumotórax a tensión requiriendo de manejo en UPC. Evoluciona estable posteriormente, dado de alta el 24/06.

Traído nuevamente a UEA el 18/07 por pie diabético izquierdo con herida talar en malas condiciones, de aproximadamente 20 días de evolución. Se decide hospitalizar para amputación infracondílea derecha. Se mantuvo hospitalizado en salas de urgencia donde se evidencia en examen físico mala perfusión distal con pulso poplíteo derecho disminuido/ausente motivo por el cual se plantea amputación supracondílea. Autorizado por familiares, se realiza intervención quirúrgica el 24/07, intrapabellón sin incidentes, paciente sale estable a recuperación y posteriormente a sala de cirugía.

En sala evoluciona en regulares/malas condiciones generales, con requerimiento de O2 suplementario, llegando a requerir de Bi-PAP por mala mecánica ventilatoria, sin alteraciones de intercambio gaseoso. Se conversa con familiares respecto a pronóstico de paciente, se llega a acuerdo de no reanimar en caso de PCR ni intubar en caso de deterioro de mecánica ventilatoria.

Se mantuvo con hemodiálisis con lo cual paciente evoluciona de manera favorable, sin necesidad de VMNI. Herida evolucionando de manera favorable, en condiciones de alta con controles ambulatorios

Diagnóstico de Egreso

DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFÉRICAS - Pie diabético

Fecha Epicrisis : 31/07/2022 08:51

Página 1 de 2

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 31-07-2022 8:51:25

Página 2 de 2

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Clínica estable, afebril, buena tolerancia oral, en condiciones de alta hospitalaria

Plan Post Alta

- Reposo relativo
- Régimen papilla + agua 250 cc 4 veces al día, 100% asistido
- Medicamentos de uso crónico
 - Carvedilol 25 mg, 1 comprimido cada 12 horas
 - Nifedipino 20 mg, 1 comprimido cada 24 horas
 - Aspirina 100 mg, 1 comprimido al día
 - Atorvastatina 20 mg, 2 comprimidos cada noche
 - Insulina NPH
- Mantener herida operatoria limpia y seca, curaciones de heridas en programa de postrados de consultorio.
- Cuidados habituales del cateter
- Continuar con diálisis trisemanal en su centro de referencia
- Control con Dr. Nicolás López en 2 semanas, pasillo 11 CDT día martes desde las 14:00hrs
- Acudir a urgencias en caso de sangrado abundante o secreción por herida operatoria o en caso de necesidad

Indicaciones

Tipo de Reposo : Movilizar En Cama

Régimen Alimentario : Papilla

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Nicolas Lopez Valenzuela
Becado/Residente

Nicolas Lopez Valenzuela
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 31/07/2022 08:51

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:34

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar